

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	食道靜脈出血 Esophageal Varices Bleeding ; EV Bleeding				
編號	A31000-Q03-W-D04	制定者	N16 蔡富卿	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/7 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解食道靜脈出血的定義、症狀、危險因子、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

當肝硬化發生時，門靜脈血會逆肝而流形成門脈高壓，即肝門靜脈壓力不正常的升高，其結果可能產生許多合併症，而食道靜脈曲張出血即為其最嚴重之合併症。正常的肝門靜脈壓為 5-10mmHg，一般不超過 6mmHg，當門脈高壓超過 12mmHg 時會引起側枝循環及系統循環亢進的現象，進而產生食道靜脈曲張而破裂出血。

（二）症狀

食道靜脈曲張在出血前並無先兆，通常要等到出血時才會產生病徵，包括了吐血及解黑便，大量出血的話會導致解血便、心搏過速，血壓不穩等；嚴重時，則可能會有低血容性休克出現而造成多重器官衰竭死亡。

（三）危險因子

- 1.肝臟壓力升高，如：日漸嚴重的肝硬化。
- 2.胸內壓升高，如：咳嗽、用力解便、抬舉重物等。

主題名稱	食道靜脈出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D04	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/7

3.食物或酒精的刺激，如：進食過辣的食物或飲用烈酒。

4.胃液的侵蝕。

(四) 常見檢查

1. 抽血：常規抽血項目，例如血紅素(Hb)、血比容(Hct)等。

2. 內視鏡檢查（胃鏡）發現病灶之處，且必要時可合併做止血措施。

(五) 常見治療

依個人病情，在治療上有所不同，分為非手術治療及手術治療

1. 非手術療法：

(1) 藥物治療：臨床上最常使用血管收縮劑使血管平滑肌收縮，導致內臟血管收縮，減少腹部組織血流量，降低門靜脈血流量回流、壓力降低來控制出血。使用血管收縮劑需監測病人是否有胸悶不適。

A. Vasopressin：會使冠狀動脈收縮造成心肌梗塞，有冠狀動脈病史者，應小心使用。

B. 體制素(somatostatin)：控制出血的效果比 Vasopressin 好，且無血管收縮的副作用。

C. Propranolol：是 β 阻斷劑，可有效降低門脈壓力，用於預防靜脈曲張出血。

(2) 內視鏡注射硬化治療(Endoscopic Injection Sclerotherapy,EIC)：即在出血處給予注射約 2cc 血管硬化劑，以破壞血管壁的內襯而產生血栓，使血管壁變硬，止血效率約 75~95%。

(3) 食道球填塞法：臨床上常用 Sengstaken-Blakemore tube（S-B 管）插入食道與胃中，再給予 200c.c.的空氣，約為 25~40mmHg，使球體膨脹並於賁門及食道壁處加壓，以控制出血。需每 6~8 小時需放鬆 30 分鐘避免組織受損。

(4) 食道靜脈瘤結紮法(Esophageal Variceal Ligation,EVL)：藉由內視鏡方式使用橡皮筋將突出的靜脈曲張處結紮起來。

主題名稱	食道靜脈出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D04	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/7

2. 手術療法：

(1) 門脈系統分流手術：主要在改變進入肝臟的門靜脈血流，以降低門脈高壓，以減少食道靜脈曲張出血機率，但仍維持肝臟適當血流供應肝細胞功能。常見的分流術為：

- A. 門脈腔靜脈分流。
- B. 脾腎分流術。
- C. 腸繫膜靜脈腔靜脈分流術。

(2) 血管阻斷(Transection)及血液停止供應法(Devascularization)：用於食道靜脈曲張急性出血期，將出血部位血管與門脈系統分開以控制出血情況。

3. 注意事項：

急性出血時，首要保持呼吸道暢通，呼吸狀況不佳或有吸入性肺炎風險時，應進行氣管內管插管以保護呼吸道；輸液及輸血具有穩定血壓之效果，但過量之輸液反而會導致門脈壓力升高，而更進一步造成持續或反覆出血。許多研究顯示使用預防性抗生素可以降低發生菌血症的機率，也可以藉此減少感染症或再出血的發生。

(六) 護理問題

1. 易受傷害：出血／門脈高壓導致食道靜脈曲張出血。
2. 易體液容積不足：出血／和有效血流量減少有關。

(七) 護理措施

1. 易受傷害：出血／門脈高壓導致食道靜脈曲張出血。
 - (1) 監測生命徵象及密切評估出血徵象，如吐血、便血，每班評估是否有臉色蒼白、頭暈、冒冷汗、脈搏變快情形。
 - (2) 教導病人使用軟毛牙刷刷牙。
 - (3) 教導勿提重物、用力解便、用力咳嗽，避免腹壓上升。
 - (4) 給予飲食衛教單張並強調避免如糙米、麻辣鍋、羊肉爐、熱湯等食物，食物宜放冷後再食用

主題名稱	食道靜脈出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D04	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/7

(5) 藥物盡量磨碎，減少摩擦食道靜脈瘤導致出血。

(6) 病人抽血後，協助按壓抽血部位 5 分鐘以上避免出血。

(7) 衛教穿寬鬆衣物，避免過緊的束口。

(8) 依醫囑指示時間進食，採漸進式進食由流質→半流質→軟食。

(9) 衛教避免服用水楊酸類（例如：Aspirin）藥物。

(10) 鼓勵病人表達其情緒與需求，並耐心傾聽，提供照護相關訊息及心理支持。

(11) 密切監測血液報告，如 Hb、Hct、PT、PTT 及 PLT 的檢驗數據等。

2. 易體液容積不足：出血／與有效血流量減少有關。

(1) 監測生命徵象、意識狀態及有無休克症狀。

(2) 評估皮膚的溫度及顏色。

(3) 觀察、記錄出血量及出血情形，並告知醫師。

(4) 絕對臥床休息，避免下床暈眩造成跌倒意外。

(5) 鼓勵家屬陪伴，給予心理支持。

(6) 依醫囑予補充液體或血液，並記錄輸出入量。

(7) 觀察糞便的量、顏色及性質，若血便立即告訴醫師。

(8) 必要時給予輸血治療。

（八）衛教指導

1. 採軟質飲食，應細嚼慢嚥，勿食用過硬、粗糙、過熱及刺激性（酒、咖啡、香料、酸、辣）、易產氣之食物，以免刺激曲張之靜脈而破裂出血。

2. 勿用力排便，注意大便顏色，避免咳嗽及舉重物。

3. 有肝硬化病史的人，應定期門診追蹤並依醫師指示做胃鏡檢查，以早期發現食道靜脈曲張情形並及早治療。

4. 避免工作過於疲累，每天應有一定的休息時間及睡眠，飯後應有短時間的休息。

5. 注意出血徵兆如：臉色蒼白、呼吸急促、心跳加快、煩躁、不安、解黑便及

主題名稱	食道靜脈出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D04	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/7

嘔血，應立即到醫院求治。

6.依醫囑按時服藥，定時門診追蹤。

7.避免持續閉氣用力之活動，減少出血的機會。

(九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 李薇莉、周繡玲(2020).消化系統疾病護理·於劉雪娥總校閱，*內外科護理學下冊* (八版，469-473頁)·台北市：華杏。
- (二) 游逸茹、莊寶玉、林秀華 (2021)。一位反覆食道靜脈曲張出血首次插管病人之加護經驗。 *臺大護理雜誌*，17(1)，53-65。 [https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6740/NTUHJN.202101_17\(1\).0006](https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6740/NTUHJN.202101_17(1).0006)
- (三) Marc, J. Z., Sherif, E., & Antonio M. L., (2022). Endoscopic Treatment of Esophageal Varices. *Clinics in Liver Disease*, 26(1), 21-37. <https://doi.org/10.1016/j.cld.2021.08.003>

七、附件

(略)

主題名稱	食道靜脈出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D04	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.10.31	2.1	修改錯別字	100 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	第六項參考資料文獻部份內容更新	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	1. 第三項第(五)目新增注意事項內容。 2. 新增第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.02.12	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	1. 第一項新增危險因子。 2. 第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.5	1. 第三項第八目之 4 刪除。 2. 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項第二、三、七目參考資料刪除。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	食道靜脈出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D04	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.6	第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	3.7	1. 第三項第二、五目修訂說明內容。 2. 第三項第七、八目增加說明內容。 3. 第六項新增參考文獻資料。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過；110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	3.8	1. 第三項第五、八目說明內容文字修訂。 2. 更新第三項第六、七目護理問題。 3. 新增第六項參考文獻資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	3.9	刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過；113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	4.0	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。